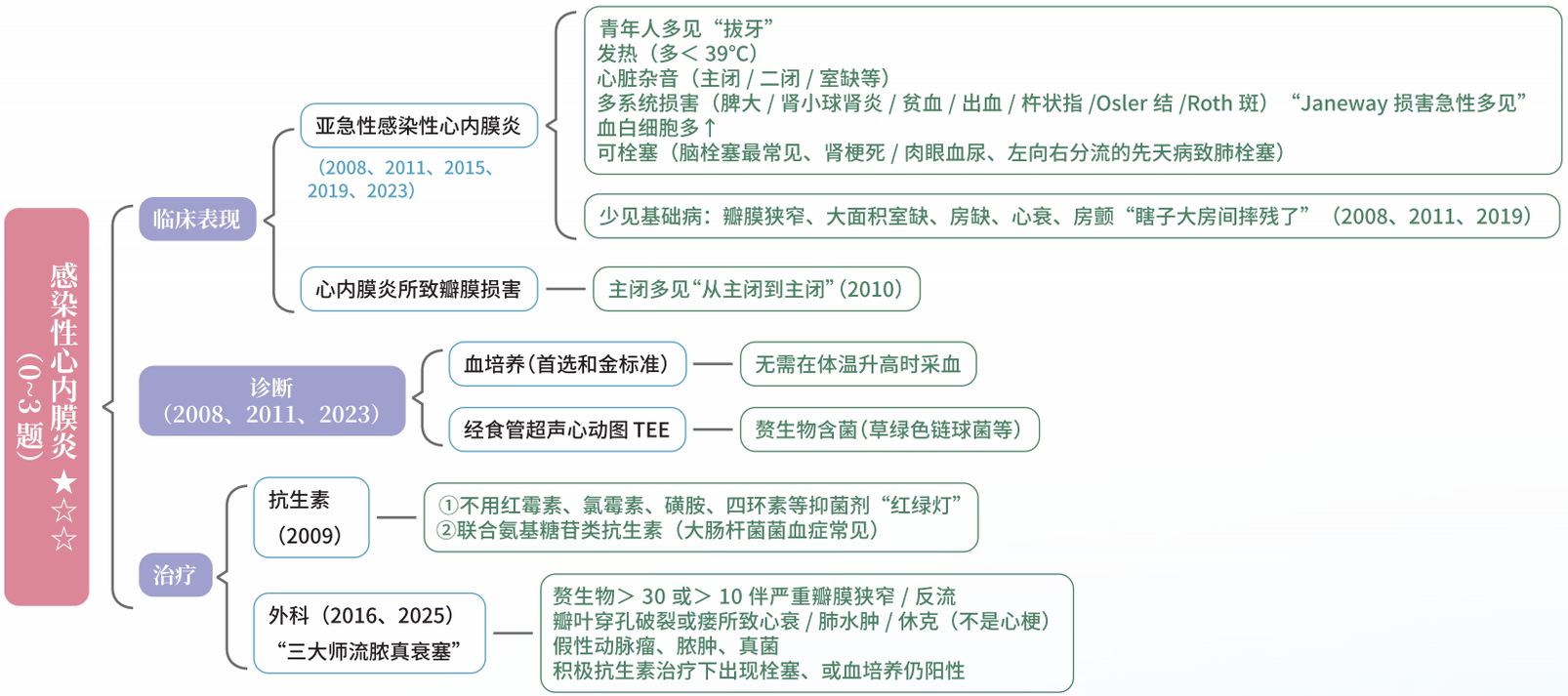

感染性心内膜炎 ★☆☆（0~3题）
临床表现
亚急性感染性心内膜炎
（2008、2011、2015、2019、2023）
青年人多见“拔牙”
发热（多＜39℃）
心脏杂音（主闭 / 二闭 / 室缺等）
多系统损害（脾大 / 肾小球肾炎 / 贫血 / 出血 / 杵状指 /Osler 结 /Roth 斑）“Janeway 损害急性多见”
血白细胞多↑
可栓塞（脑栓塞最常见、肾梗死 / 肉眼血尿、左向右分流的先天病致肺栓塞）
少见基础病：瓣膜狭窄、大面积室缺、房缺、心衰、房颤“瞎子大房间摔残了”（2008、2011、2019）
心内膜炎所致瓣膜损害
主闭多见“从主闭到主闭”（2010）
诊断
（2008、2011、2023）
血培养（首选和金标准）
无需在体温升高时采血
经食管超声心动图 TEE
赘生物含菌（草绿色链球菌等）
治疗
抗生素
（2009）
①不用红霉素、氯霉素、磺胺、四环素等抑菌剂“红绿灯”
②联合氨基糖苷类抗生素（大肠杆菌菌血症常见）
外科（2016、2025）
“三大师流脓真衰塞”
赘生物＞ 30 或＞ 10 伴严重瓣膜狭窄 / 反流
瓣叶穿孔破裂或瘘所致心衰 / 肺水肿 / 休克（不是心梗）
假性动脉瘤、脓肿、真菌
积极抗生素治疗下出现栓塞、或血培养仍阳性